

 소아과 13주차 SUMMARY 공지사항

-

지난주에 했던 것 중 질문하신 중요한 사항

:

상풍 = 삼소음 / 상한 = 연교패독산(형방패독산 + 연교,금은화)

2절 감모

3. 辨證施治

2) 감모

(1) 風寒感冒

증상	發熱輕, 惡寒重, 頭痛, 無汗, 咽喉痒, 鼻塞咳嗽, 口不渴, 咽不紅, 舌苔薄白, 脈浮緊 풍한감모와 풍열감모의 감별 : 가래와 콧물이 묽으면 풍한감모, 진하면 풍열감모
치법	辛溫解表 (신온해표)
치방	1. 蔥豉湯(충시탕) 2. 杏蘇散(행소산) 3. 荊防敗毒散加減(형방패독산가감) 4. 忍葛飲(인갈음)

(2) 風熱感冒

증상	發熱重, 惡寒輕, 有汗 或 少汗, 咽喉紅腫疼痛, 口乾而渴, 鼻流黃涕, 淡白而黃, 舌薄白 或浮黃, 脈浮數
치법	辛涼解表 (신량해표)
치방	1. 銀翹散加減 或 桑菊飲加減 (은교산가감 혹, 삼국음 가감) 2. 散熱飲 (산열음)

(3) 暑邪感冒 교수님曰 : 나는 청서익기탕을 많이 사용한다

병인	여름에 서사로 인해서 정기가 손상되어 비위에 영향을 미쳐 내습이 생겨 유발
증상	高熱汗少, 頭痛身重, 困倦嗜睡, 納呆便瀉, 胸悶, 或嘔吐腹痛, 或鼻塞流涕, 咳嗽不甚, 口渴而不多飲, 苔白, 或滑膩, 舌質偏紅, 脈浮濡而數
치법	清暑解表 (청서해표)
치방	1. 新加香薷飲加減 (신가향유음가감) 2. 身熱,頭痛,腹痛 : 加味二陳湯(가미이진탕) 3. 抽搐似驚風, 煩渴, 汗熱, 便黃紅 : 加味香薷飲(가미향유음)

(4) 時行感冒(風溫,毒感)

병인	주기적으로 새로운 변종 인플루엔자들이 생겨서 역학적으로 문제가 되고 있다.
증상	1. 惡寒, 發熱, 咽喉痛 등의 症狀이 棼하다 2. 유행성으로 누구에게나 형증이 일정하다. 3. 병리과정은 온역병의 병리과정을 거쳐 초기의 오한증상이 심하지 않고 곧 발열로 시작하여 급속히 고열이 되는 경우가 많고, 고열로 인한 체액의 소모로 정기허탈이 가중된다.
치법	清熱解肌, 鎮痛 (청열해기, 진통)
치방	1. 柴葛解肌湯 (시갈해기탕) 2. 麻杏甘石湯 合 銀翹散 (마행감석탕 합 은교산) 3. 鎮通 : 九味羌活湯 (구미강활탕)

3) 협증

협증은 소아감기의 특징!

(1) 夾食(表裏筆證)

병인	- 內傷飲食感風寒 1. 飲食不節로 傷食停積하고 感氣에 걸린 경우(便秘를 수반) : 食滯를 치료 2. 感氣에 걸려 脾胃不運으로 滯한 경우(복통, 설사를 수반) : 감모를 치료 음식에 체해서 면역력이 떨어져서 감기에 걸린 것 or 감기 바이러스가 소화장에 가 불러일으킨 것 평상 시 소화기능이 많이 떨어진 아이
증상	發熱(微熱), 頭痛, 惡寒, 食慾腕悶 噯氣, 口中有臭味, 嘔吐酸穀, 肚腹膨滿, 腹部熱感 腹痛拒按, 泄瀉 或 大便不通, 小便短少
치법	疏導和中 (소도화중)
치방	1. 열상이 심하지 않은 경우: 藿香正氣散 (곽향정기산) ★★ 이진탕 (반하, 진피, 복령, 감초) + 평위산(백출 진피 후박 감초) + 곽향(이기)+길경(목부음)+ 소엽(발한해표)+ 백지(코감기)+ 대복피(복부팽만) 2. 表邪가 解한 경우: 平胃散 加味 3. 銀翹散 合 保和丸 4. 正理湯 5. 乳食에 내상되고 풍한에 외감됨: 太和飲 6. 간열 구역을 겸하고, 우측액각부에 청색이 나타남: 人蔘羌活散 7. 藿香正氣散 合 敗毒散 기침 치료에 대한 처방이 하나도 안 들어가기 때문 에 패독산을 넣을 수 있다 8. 寒熱如瘧 惡心 少食 : 人蔘養胃湯 9. 身熱 煩渴 腹滿 嘔逆及大便泄: 香葛飲

(2) 夾熱

병인	평소 有熱한데 感風寒하여 鬱蒸化火함(陰虛內熱 + 外感風熱)
증상	顏面紅赤, 唇焦, 口鼻乾燥, 初期에는 惡寒하나 高熱, 口渴喜冷, 心神煩躁 不寧, 譫語, 二便閉結 (熱性體質에서 多發하며 扁桃腺이나 咽喉炎이 있을 때 열을 동반하는 경우가 많으므로 扁桃나 咽喉에 炎症이 있는지 확인한다. 대부분 편도비 대(陰虛內熱)하다.)
치법	清裏熱(리열증상까지 진행되었을 시), 疏風散熱, 表裏俱清
치방	1. 실증의 편도선염 등 諸炎症性 질환 : 仙方敗毒湯 경희대에서는 상한에 목이 붓고, 독감이 있으면 이것을 많이 처방하기도 한다 2. 四時感冒로 인한 두통 오한 발열 비색 사지통 해수 인후종통 : 玄黃 解毒湯 3. 仙方活命飲 중기가 안 생김 4. 雙解通聖湯 풍열의 대표방이지만, 너무 써서 석고 활석 대황 등을 빼도 충분 히 효과가 난다 5. 위장적열로 변비를 겸한 편도선염을 비롯한 육경지열 특히 상초열을 치한다 : 涼膈散 6. 熱輕일 경우: 天水散 7. 羌活散 8. 面赤 鼻塞 口渴 痰嗽症 實熱 : 柴葛飲

(3) 夾驚

병인	邪熱의 자극으로 神志不寧한 경우
증상	身熱煩躁, 顔色青赤, 睡臥不安, 膽怯心驚, 驚厥, 舌尖紅, 脈弦
치법	散邪清熱, 清熱平肝, 清熱解表, 安神鎮驚
치방	1. 신열 번조 안색청적 睡臥不安(수와불안) 膽戰心驚(담전심경) : 疏解散 백강잠 : 한방진경제(천마, 백강잠, 조구등 등) 2. 신열 번조 안면청적 수와불안 : 涼驚丸

	3. 경계불녕, 夜臥不安(야와불안)한 경우 : 柴胡溫膽湯
	4. 琥珀抱龍丸
	5. 手掌心汗, 이마의 중앙부에 靑紋 - 驚輕者면 先發表而後安心神 : 加味人蔘羌活散

* 교수님의 비방 (책에도 안 넣어놨다고 하시네요)
기본 : 객향정기산(소화가 안되면서 감기가 걸린 것)
+ 추가 증상
인후통 : 포공영 어성초 천화분 현삼
가래 : 패모, 나복자
콧물 : 유근백피, 천호, 신이화, 창이자
기침 : 상백피, 지골피, 전호

(4) 夾痰

증상	咳嗽較劇, 咳聲重濁, 喉中痰鳴, 氣促, 苔厚膩, 脈浮滑
치법	清肺化痰, 溫肺化痰
치방	1. 香蘇散 加貝母, 瓜蒌仁 2. 三子養親湯 3. 비허생담: 二陳湯

* 임상적 분류

- 高熱型: 高熱이 나는데 흔히 咽喉炎이나 扁桃腺炎이 있을 경우가 많다.
- 荊防敗毒散, 涼膈散, 必用方甘桔湯, 玄黃解毒湯, 仙方敗毒散 등을 加減 使用한다.
- 胃腸型 : 胃腸障礙를 초래하는 경우
- 대개 藿香正氣散, 不換金正氣散, 香葛湯, 正理湯, 陶氏平胃散 등을 加減使用하나 일반적으로 人蔘養胃湯에 人蔘을 祛하고 柴胡, 蘇葉, 香附子, 黃芩, 山楂, 麥芽 등을 加한다.
- 痙攣型 : 자주 놀라며 경련을 일으키는 경우
- 青皮, 釣鉤藤, 白僵蠶, 香附子, 蟬退 등의 약물을 常用하며 抱龍丸, 溫膽湯을 사용한다.
- 咳嗽型 : 기침감기
- 敗毒散에 黃芩, 荊芥, 防風, 杏仁, 桑白皮, 玄蔘 등을 가한다.
- 關節痛型 : 몸살감기
- 肢節痛이 대표적 症狀이고 열이 있으며 消化機能에 이상이 없으면 雙敗湯, 九味羌活湯 合 葛根解肌湯을 쓴다.
- 鼻涕型 : 콧물감기
- 小青龍湯, 加味二陳湯 등을 쓴다.
- 多汗型 : 땀이 많이 나는 경우
- 고열보다는 저열을 수반한다. 桂枝湯이나 補中益氣湯 등에 黃芪, 白芍(炒), 防風 등을 첨가한다.

4. 鍼灸治療

解熱시키되 體溫이 37°C 이하면 大椎, 身柱, 靈臺에 灸 3~5장, 37°C 이상이면 十井穴과 後谿 出血

- 鼻塞 : 印堂, 上星, 四關
- 頭痛 : 百會, 天柱, 風池
- 咳嗽 : 太淵, 尺澤, 天突
- 鼻沸 : 迎香
- 咽喉痛 : 少商, 少澤, 商陽, 關衝에서 出血後에 合谷, 尺澤 刺鍼

5. 서의학적 질환

- 상기도는 비강과 구강, 인두, 편도와 아데노이드로 구성되어 있다.
- 주위에 부비동과 중이가 있으며, 눈과 식도와 연결되어 있어 그곳으로 질병이 파급될 수도 있고, 또 다양한 기능 장애를 일으킬 수 있다.
- 따라서 상기도 감염에서는 부비동염과 중이염이 자주 합병하고, 또 눈의 증상과 삼킴 장애 또는 위식도 역류와 같은 증상이 자주 동반될 수 있다.

1) 급성 비인두염

- 급성 비인두염은 소아기의 가장 흔한 질환으로 감기 (Common cold), 상기도염(URI)과 동의어로 쓰인다.
- 어른보다 소아에서 증상이 심하며, 합병증으로 부비동염과 중이염이 잘 생긴다.

(1) 원인

- 200가지 이상의 바이러스가 원인이 되며, 이 중 rhinovirus가 가장 흔한 원인으로 50% 이상을 차지하고, 코로나바이러스(coronavirus), 호흡기 세포융합 바이러스(RSV), 인플루엔자 바이러스 등도 원인이 된다.
- 감기는 연중 내내 발생하지만, 초가을부터 늦은 봄까지 가장 흔하다.
- 특히 학기 초를 중심으로 4월과 9월에 흔히 발생한다.
- 이는 집단생활과의 연관성을 시사하고, 또 감기의 가장 흔한 원인균인 rhinovirus가 4~5월과 8~10월에 유행하는 양상과도 연관이 있을 수 있다.
- 발생 빈도는 노출 횟수에 비례하며 기도 면적에 따라 다르다.
- 어린 소아는 1년에 평균 6~8회 정도 감기에 걸리며, 10~15%에서는 연간 12회를 앓기도 한다.
- 특히 3세 이하에서 흔히 발생하고 나이가 들어가면서 빈도는 점차 줄어든다.

(2) 증상

- 복기는 1~3일이며 코 증상이 모든 환자에서 나타난다.
- 콧물과 코막힘이 주증상이고 재채기가 동반되기도 한다.
- 코막힘으로 코가 뒤로 넘어가거나(post-nasal-drip) 입호흡(mouth breathing)을 하게 됨으로써 목에 이물감과 통증을 느낄 수도 있다.
- 콧물은 병이 진행하면서 끈끈해지고 누런색을 띄기도 하지만 이것만으로 세균 감염으로

판단할 수는 없다.

- 감기는 나이가 어릴수록 증세가 심하며 발열이 흔히 동반되고 구토와 설사 등의 증상도 동반된다.
- 발열과 같은 전신 증상들은 대체로 4~5일 내에 사라지며, 코 증상은 1주 정도 더 지속
- 합병증으로 중이염이 발생하였을 때는 발열이 더 오래 지속될 수도 있다.
- 연장아에서는 초기에 단순히 코의 건조감과 소양감, 인두 불쾌감과 두통의 증상이 나타나다 수 시간 내에 묽은 콧물과 기침, 그리고 재채기가 시작된다.
- 두통, 전신 쇠약, 식욕감퇴, 근육통과 오한 등의 전신 증상이 자주 동반되지만 발열은 심하지 않다.

(3) 합병증

- **코와 인두 주위의 조직에 2차 세균감염에 의한 질병들을 합병증이라고 할 수 있다.**
- **중이염**이 가장 흔하고 **부비동염**, **인두 후부 및 편도 주위 농양**과 **안와 주위 연조직염** (cellulitis)이 있고, **알레르기 비염** 또는 **천식의 악화**도 합병증으로 자주 나타난다.

(4) 감별진단

- 소아에서는 많은 질환들이 감기의 증상으로 시작하기 때문에 질병의 진행 과정을 관찰하는 것이 매우 중요하다.
- 단순한 감기인지, 2차 세균 감염, 특히 폐렴이 동반되었는지, 합병증이 동반되었는지를 반드시 생각해 보아야 한다.
- 원인균이 달라도 증상이 비슷한 경우가 많아 마치 알레르기 환자에서 비슷한 증상이 반복되는 것과 같은 인상을 주기 때문에 알레르기 질환과의 감별이 필요하다.
- **알레르기성 비염은 열이 없고 콧물은 화농성으로 발전하지 않으며, 대개 재채기와 코와 눈의 가려움증이 동반된다.**

2) 급성 구강염

소아에서 흔한 구강염으로는

- ↳ 단순헤르페스바이러스(Herpes simplex virus)에 의한 구내염
- ↳ 콕사키바이러스(Coxsackievirus)나 에코바이러스(Echovirus)와 같은 장바이러스에 의한 헤르페스목구멍염(Herpangina)
- ↳ 손발입병(hand-foot-mouth disease),
- ↳ adenovirus에 의한 인두결막열(pharyngoconjunctival fever)
- ↳ 칸디다 구내염이 있다.

- 대부분 자기한정(self-limited)의 임상 경과를 보이는 질환이기도 하지만 헤르페스 구내염은 재발 감염으로 지속되기도 한다.

6. 섭생법

1. 항균제의 사용은 감기 자체에 대해서나 합병증(기관지염 등)의 예방에 있어서 아무 효과도 없다.
2. 안정을 취하고, 충분한 영양 공급, 가습 등으로 수분과 비타민을 공급하는 것이 중요하다. 영양은 충분히 공급시켜 주는데 生冷之物, 자극성 음식물, 기름진 음식은 금하는 것이 좋으며 밥에 따르는 부식물도 담백한 것으로 하고, 평소에 좋아하는 것을 주되 가능한 따뜻한 것이 좋다.
3. 코가 막혀서 젖을 잘 빨지 못할 때에는 생리 식염수를 몇 방울 떨어뜨려 흡인해 주는 것이 일시적인 증상 완화에 도움이 된다. 코의 분비물을 흡입기로 제거해 준다. 임시로 엮드려 재우는 것도 분비물들을 밖으로 흐르게 하는데 도움이 될 수 있다.

4. 발열과 통증이 심하면 미지근한 물찜질(tepid water massage)로 해열을 돕도록 하고 가능한 약물의 사용은 피하는 것이 좋다.

5. 항히스타민제는 점막 건조 및 섬모 운동 장애를 초래하여 오히려 2차 세균감염의 위험성과 부비동염 및 중이염의 발생 빈도를 높게 하기 때문에 급성 증상의 치료에 국한하여 사용하는 것이 좋다.

6. 호흡기와 소화기의 면역력을 증강시켜주는 처방을 주기적으로 복용시키는 것이 효과적이다. 생활 환경적으로는 바이러스의 감염 경로를 차단하는 것이 가장 바람직하다. 구강 위생과 손 씻기 습관을 가지는 것이 감기 예방의 가장 중요한 수단이다. 유행 시에는 단체 생활과 대중이 모인 장소를 피하여야 하고, 특히 면역이 미숙한 어린 아이나 질병을 앓고 있는 아이는 이러한 조치를 철저히 해주어야 한다. 옷을 두껍게 입히지 않도록 한다. 한랭에 대한 적응 능력이 약해지기 때문이다.

3절 해수

1. 개요

- 기침 : 소아에서 가장 흔한 肺系 증후의 하나로 호흡기로부터 분비물이나 이물을 제거하기 위한 하나의 생리적 방어 현상
- 서의학에서 후두개염, 모세기관지염, 기관지염, 폐렴 등에 해당

- 外感이나 內傷으로 인한 여러 가지 급·만성 병증에서 기침이 나타날 수 있음.
- 咳嗽의 病理는 肺의 변화와 관계가 있으며 신체의 各部는 서로 연관되어 다른 臟腑의 病이 肺에 영향을 주어 咳嗽을 일으키기도 한다고 보아 《內經》에서 “肺病則咳”, “五臟六附, 皆令人咳, 非獨(작)肺也”라 하였다.

- 咳와 嗽는 漢代以前까지는 구분되지 않았음.
- 후세에 河間의 《病機式要》를 인용한 《幼科心法要訣》

“咳嗽爲有聲有痰, 因肺氣受傷, 動乎脾濕而然也; 咳爲無痰而有聲, 肺氣 傷而不清也; 嗽爲無聲而有痰, 脾濕動而有痰也” 같이 咳와 嗽로 구분함.

- 《幼幼集成·咳嗽證治》에서의 “因痰而嗽者痰爲主, 主治在脾; 因咳而動痰者, 咳爲重, 主治在肺”와 같은 인식은 임상적 의의가 크다고 볼 수 있음.
- 또 肺는 嬌臟(교장)이고 소아는 폐상부족 원기허약하여 외사에 감염되기 쉽고, 잘못 치료하면 肺氣를 損傷하여 병이 오래도록 낫지 않는다.

2. 病因病理

- 총괄적으로 咳嗽의 病位는 肺에 있고, 기본 병리는 肺失淸肅(폐실청숙), 痰濁內阻, 日久則肺氣受傷이다.

1) 病因

▣ 外因 : 外邪가 肺에 침습한 경우로 소아는 腠理不密하고 衛外不固하여 外邪를 받기 쉬운 생리적 특징이 있음.

▣ 內因 : 臟附機能의 失調가 肺에 영향을 주거나 乳食生冷, 食積, 혹은 稟賦不足, 脾胃 虛弱으로 痰濕이 內生하여 肺에 영향을 주면 기침이 나타난다.

2) 病理

(1) 感受外邪, 肺失淸肅

- 小兒는 形氣未充하고, 肌膚가 유약하며, 衛外 기능이 비교적 좋지 못함.
- 더욱이 寒溫의 변화에 적응하기 어려워 겨울과 봄철의 기후변화가 많은 시기에는 六淫의 邪氣가 침범하기 쉬움.
- 口鼻나 皮毛로 침입한 邪氣는 肺에 영향을 주어 宣降 기능의 실조를 초래함.
- 肺는 宣散과 肅降의 기능이 있는데 外邪가 침입하면 肺氣가 울폐하여 宣發되지 못하고 肅降의 기능이 원활하지 못하여 肺氣의 출입 호흡에 영향을 주어 咳嗽가 나타남.

(2) 痰濁內生,貯肺作咳

- 小兒는 脾胃가 虛弱하여 乳食, 生冷, 積熱로 손상을 받기 쉬우므로 脾의 運化 기능이 실조되어 水穀이 精微로 化生되지 못하고 痰濁을 형성하여 肺에 저장되어 기도를 막아 肺氣가 통창하지 못하여 咳嗽를 일으킨다.
- 이른바 "脾胃生痰之源, 肺爲貯痰之器."가 그것이다.
- 痰은 脾濕이 응취해서 생성되며 腎의 津液이 변화하여 생성되기도 한다.
- 腎陽이 허하면 暖土하지 못하여 脾虛로 인해 痰을 형성하고, 水를 제압하지 못하여 飲이 생성되는데, 腎虛로 인한 咳는 어른에 비해 적다.

(3) 素體虛弱,肺脾受損

- 稟關不足하여 체질이 허약한 경우 혹은 外感咳嗽가 오래도록 낫지 않고 正氣를 손상하여 더욱 外邪를 반복해서 感受하기 쉬우므로 咳嗽가 오래되어 脾肺에 손상을 주어 內傷咳嗽로 발전한 肺陰耗傷이나 脾肺氣虛의 證이 나타난다.
- 그 외 병이 오래되어 肺津이 耗傷하여 腎陰不足을 일으키기도 한다.

3. 辨證施治

1) 外感咳嗽

(1) 風寒咳嗽

원인	小兒가 風寒을 感受하여 발생 (풍한감수)
증상	咳嗽噴嚏, 流涕, 鼻塞聲重, 咳吐痰涎(痰芒 清稀), 頭痛, 身熱有汗 또는 無汗, 脈浮緊
치법 치방	1. 疏解表邪: 蔘蘇飲(삼소음) 풍한감초처럼 풍한해수에도 삼소음 처방 2. 散風祛痰止咳: 加味金沸草散 3. 溫肺散寒: 加味華蓋散 4. 脈緊,惡寒,寒熱,無汗,煩燥,不渴: 加味三拗湯 5. 肺盛復有風冷, 胸滿短氣, 氣急喘嗽上氣: 當先散肺, 後發散風冷: 瀉白散

(2) 風熱咳嗽(感氣轉移,流行性感冒)

증상	咳嗽不爽, 痰黃粘稠, 不易咯出, 口渴咽痛, 鼻流濁涕, 伴有發熱 頭痛, 微汗出, 舌苔 薄黃質紅, 脈浮數
치법	疏風肅肺(疏風清熱爲主, 肅肺止咳爲輔), 辛涼解表 宣肺利痰
치방	1. 銀翹散加味 2. 桑菊飲 3. 加味香蘇散 교수님이 많이 쓰시는 처방 향소산 + 소시오탕계열(시오 반하) + 맥문동(풍열) + 행인(지해) + 오미자(렴폐) + 지각길경(목 부음)

(3) 肺熱咳嗽(火嗽)

원인	溫熱 또는 가을에 燥邪를 感受하여 熱이 肺를 傷하여 발생 (화열이 폐금을 熏擾(훈요))
증상	咳嗽頻頻, 面紅咽乾, 粘稠한 痰과 음식물을 구토하는데 穢臭(에취)한 황색 담, 脈滑數苔黃, 舌紅苔黃, 呼吸氣粗 口臭(穢臭), 便秘
치법	瀉肺清熱, 清熱通下
치방	1. 加味瀉肺散(加味瀉白散:加味香蘇散 合 瀉白散) 2. 肺熱이 大腸으로 轉移되어 便秘한 경우: 涼膈散 3. 有聲痰少, 面赤, 煩渴: 清金降火湯

2) 內傷咳嗽

(1) 食積咳嗽

원인	소아가 乳食에 상하여 脾胃가 運化를 못하여 痰이 발생하고, 이 痰이 肺에 上蒸하여 발생 熏擾(훈요))
증상	咳嗽痰壅, 胸腹膨滿, 呼吸氣促, 脘悶噯飽, 大便或瀉, 或秘, 不思飲食, 五更咳, 手足心熱, 睡臥不安(胃不和不眠), 苔厚黃膩, 脈沈滑
치법	消導化積(便瀉), 攻下痰食(便秘)
치방	- 麵麥二陳湯(便瀉) - 蘇葶滾痰湯(便秘) - 香附丸 : 食積咳嗽에 반드시 과루인과 청고를 사용 - 食物로 인해서 痰이 生하여 胸滿, 噯酸(히산) : 杏橘飲

(2) 脾肺氣虛咳嗽(肺寒咳嗽)

원인	小兒의 肺氣가 원래 허약한 데다 起居, 飲食의 不慎으로 寒冷을 感受하거나 生冷한 것을 좋아하여 寒邪傷肺한 경우 알레르기 체질이 있는 아이들은 기침을 오래함 -> 비폐기허해수 소음인 아이들은 비가 원래 허함 -> 비폐기허해수
증상	顔色㟟白, 鼻流涕, 或發身微熱, 喉有痰聲, 痰多清稀, 咳嗽綿綿, 書靜夜甚, 呼吸氣冷, 怯寒背冷, 四肢不溫, 大便溏薄, 小便清長, 脣舌淡, 胖嫩, 舌苔白潤, 脈沈細
치법	溫肺散寒 祛痰
치방	1. 肺虛飲冷咳嗽, 面色鮮白痰涕清 : 聖惠橘皮飲 2. 久不愈 肺虛有熱 : 補肺阿膠散(止嗽生津) 3. 半夏溫肺湯 4. 六君子湯 5. 錢氏白朮散 加 桑白皮 地骨皮 前胡 蘿菈子炒 半夏薑製

(3) 陰虛燥咳 = 폐신음허해수

증상	乾咳無痰 或 少痰而粘, 不易咯出, 喉痒聲嘶, 口渴咽乾, 手足心熱, 或咳嗽帶血, 午後潮熱, 舌紅少苔, 脈細數
치법	滋陰潤燥, 清肺止咳
치방	1. 左歸飲加味 2. 沙蔘麥門冬湯加減 3. 金水六君煎

4. 鍼灸治療

1) 毫鍼療法

- 1. 外感風寒: 列缺 合谷 肺俞 外關
- 頭痛에는 風池上星 肢體인 경우 崑 復溜를 加한다.
- 2. 外感風熱: 尺澤 肺俞 曲池 大椎
- 咽喉痛에는 少商을 點刺出血한다.
- 汗出不暢에는 合谷을 加하고 多汗하고 熱이 물러 가지 않으면 陷谷 復溜를 加한다.
- 瀉法을 사용하고 留하지 않는다.
- 每日 1回 실시 濕痰侵肺: 脾俞 肺 太白 太淵 豐隆 合谷
- 3. 濕痰侵肺 : 脾俞 肺俞 太白 太淵 豐隆 合谷
- 咳嗽兼喘者는 定喘穴을 加하고 胸膈痞悶하면 足三里 內關을 加한다.
- 瀉法을 사용하고 背俞穴에 자침한 후 溫和灸를 사용한다. 每日 1回 실시

2) 三稜針療法

- 太衝 少商 豐隆 風門을 取하며 三稜針으로 點刺出血하는데 每日 1回 兩側穴을 交代로 사용하며 3日을 1療程으로 한다.
- 1療程으로 회복되지 않은 경우에 2日을 쉰 후 이어서 治療를 시작하며 外感咳嗽에 사용한다.

3) 耳鍼療法

- 肝 肺 神門 氣管을 하여 兩側에 중등도의 자극으로 자침한다.
- 유침은 20분 격일 1회로 하여 10회를 1療程으로 한다.
- 이외에 王不留行씨를 붙여 사용하는데 각종 에 응용한다.

5. 서의학적 질환

1) 기관지염(Bronchitis)

- 어떤 특수한 원인으로 생기는 질환이 아니라 기침을 하며 조잡한 수포음(rhonchi)이 들리면서 폐렴 증상이 없는 경우를 말함.
- 대개 상부, 하부 기도 질환과 같이 오는 수가 많으며, 기관지염 단독으로 오는 일은 드뭄.
- 동반되는 질환에 따라 후두기관지염 (laryngotracheobronchitis), 기관기관지염 (tracheobronchitis), 또는 천식 또는 알레르기 기관지염(asthmatic or allergic bronchitis) 등으로 불리는 경우가 많음.

(1) 급성 기관지염(Acute bronchitis)

① 원인

- 급성 기관지염의 원인은 비인두염과 같은 상기도 감염과 대동소이하여 대부분 바이러스지만, S.pneumoniae, Moraxella catarrhalis, H.influenzae에 의한 2차 세균 감염도 가능.
- 인플루엔자, 백일해, 홍역, 장티푸스, 성홍열과 디프테리아 등도 감염의 원인이 됨.

② 증상

- 대표적인 증상은 가래 기침.

- 대체로 3~4일간의 가벼운 감기 증상이 있는 뒤 나타나고 점차 심해지면서 가래는 점액성에서 화농성으로 된다.
- 기침도 심하여 가슴의 통증을 느끼게 되고 구토도 동반한다.
- 대개 5~10일 내에 객담은 다시 묻어지고 기침은 단계적으로 없어진다.
- 열은 대체로 동반하지 않고, 있더라도 미열 정도로 그친다.
- 원인 바이러스의 종류에 따라 비인두염, 결막염 또는 피부 발진이 동반될 수 있음.
- 청진 소견은 병변의 침범 범위에 따라 천명 또는 수포음을 들을 수 있음.
- 합병증은 거의 없으나 영양 결핍이나 면역력이 저하된 소아에서는 중이염, 부비동염과 폐렴이 잘 옴.
- 급성 기관지염이 반복되는 경우 호흡기 기형, 기도 내 이물, 기관지 확장증, 면역 결핍증, 결핵, 알레르기, 부비동염, 편도염과 낭성섬유증의 가능성을 주의 깊게 살펴보아야 함.

③ 치료

- 대증 요법 외에 다른 특별한 치료 없이 대부분 약 2주가 되면 자연히 회복됨.
- 객담 배출을 용이하게 하기 위한 체위 변동과 같은 호흡 물리 요법과 수분 공급이 도움
- 습도를 올려 주면 편안함을 느끼게 해 주지만 병의 경과를 단축하지는 못하는 것으로 알려져 있다.
- 진해제는 흉통을 동반할 정도이거나 수면을 방해할 정도의 심한 기침에는 도움을 주지만, 객담의 배출을 저해하여 점도를 높이고 2차 세균 감염을 일으키게 할 수 있기 때문에 적절한 판단을 내려 사용해야 한다.
- 항히스타민제는 분비물을 건조하게 하여 도움이 안 됨.
- 항생제는 세균 감염이 확인되었을 때에는 사용해야 하지만, 병의 경과를 줄이거나 합병증을 예방하기 위해 사용하는 것은 도움이 되지 않음.

(2) 만성 기관지염(Chronic bronchitis)

- 만성 기관지염은 성인에서 연속 2년 이상, 매년 3개월 이상 가래와 기침이 있는 경우로

정의하지만 소아에서는 적용되는 기준이 없다.

- 소아에서의 만성 기관지염은 독립적인 질환이라기보다는 기관지 감염 외의 원인에 의한 경우가 많다.
- 예컨대, 기관지 천식, 후비루를 동반한 상기도 감염, 면역 결핍, 해부학적이상, 환경성 질환, 낭성섬유증, 섬모 이상 운동 및 기관지 확장증 등에 의한 경우들이다.
- 영아에서는 잘못된 수유 방법과 삼킴 장애, 위식도 역류에 의한 기도 흡인도 드물지 않은 원인이 된다.

① 원인

- 흡연, 간접 흡연, 마리화나와 같은 환경에 노출되어 증상이 나타나는 경우가 많음.
- 이 밖에도 오존과 이산화질소(NO2), 분진과 같은 대기 오염물도 만성 호흡기 증상과의 연관성이 충분히 있음을 주지해야 함.
- 특히, 흡연은 기관지염 및 여러 급·만성 폐질환의 증가 및 악화와 관련이 있음.

② 증상

- 주증상은 기침이며 대개 객담을 동반함.
- 흉통을 호소하기도 하며, 특히 밤에 증상이 나빠짐.
- 천명이 현저하기도 하며 진찰 소견은 급성 기관지염과 유사함.

2) 급성 세기관지염(Acute bronchiolitis) ★★★

- 급성 세기관지염은 영아에서 흔히 볼 수 있는 **하부 호흡기 질환**으로 작은 기도의 염증 폐쇄로 인하여 발생.
- 기관지의 구조적 약점을 많이 가지고 있는 **생후 2세 이전의 영아**에서 주로 발생하며 돌 전후에 가장 높은 발생 빈도를 보이고 **영아 입원의 가장 흔한 원인**.
- 연장아나 성인들은 영아보다 세기관지 부종에 더 잘 적응하기 때문에 바이러스에 감염이 되어도 세기관지염의 임상적 증상이 잘 나타나지 않음.

- 겨울과 초봄에 가장 많이 발생하며, 산재성 또는 유행성으로 발생.

(1) 원인

- 대부분 **바이러스**에 의해 발생하고, respiratory syncytial virus(**RSV**)가 **원인균의 50%이상**을 차지.
- 사회 경제의 발전이 두드러지면서 환자 수가 많이 증가하는데 이는 **놀이방 등의 집단 시설을 이용하는 경우가 많아지고, 미숙아의 생존율이 높아진 데에 기인**한다고 함.
- 바이러스 감염의 근원지는 가족 구성원으로 대체로 1주일 전에 가족 중에 비슷한 호흡기 질환을 앓았다는 이야기를 듣게 됨.
- 급성 세기관지염은 **기도의 부종, 점액이나 세포 탈락물(cellular debris)의 축적**으로 인한 **세기관지의 폐쇄를 특징**으로 함.
- 병변의 진행은 정상적인 가스 교환을 저해하여 질병 초기에 저산소증이 생김.
- 일반적으로 호흡수가 빨라지면 초기에는 동맥 내 산소압이 떨어지고, 호흡곤란이 더 진행되면 CO2가 축적됨.

(2) 증상

- **첫 증상은 대부분 맑은 콧물이나 재채기를 동반하는 경한 상기도 감염**이고, 비교적 빠른 속도로 진행하여 수일 안에 **발작적인 천명성 기침**으로 이어지면서 **심하게 보채고 호흡 부전**의 증상까지 나타나게 됨.
- **호흡이 빨라져 수유하기도 힘들어 짐.**
- 대체로 발열은 동반하지 않지만, 폐실질까지 병변이 퍼지면 **중등도의 열(38.5~39도)**을 동반하기도 함.
- 진찰상 **빠른 호흡과 폐의 과팽창, 그리고 흔히 심한 호흡곤란**을 보임.
- **호흡수는 60~80회/분**의 범위이며 심한 환기 부족으로 **청색증**을 보일 수 있음.

- 코를 벌렁거리며 (flaring of alae nasi), 호흡 보조 근육의 사용으로 인한 늑간 및 늑간 하부의 함몰이 일어남.
- 과도한 폐 팽창으로 간과 비장이 늑골 아래에서 만져질 수 있음.
- 광범위한 미세 수포음이 흡기 말기와 호기 초기에 들릴 수 있음.
- **호기 시간이 연장되며, 보통 천명을 들을 수도 있음.**
- 아주 심한 경우에는 거의 완전하게 세기관지의 폐쇄가 일어나서 호흡음은 거의 들을 수 없게 됨.

- 흉부 X선상 폐의 과팽창과 측면 사진에서 흉곽 전후경의 증가를 보임.
- 환아의 약 30%에서 폐쇄로 인한 2차적인 무기폐나 폐포의 염증에 의한 산재된 폐경화(consolidation)를 보임.
- 흉부 X선 검사만으로는 초기의 세균 폐렴과의 감별진단이 어려움.

(3) 경과 및 예후 (서술형)

- 일반적으로 기침과 호흡 곤란이 시작된 후 처음 **48~72시간** 동안에 증상이 가장 심하다가 빠른 속도로 호전되어 수일 내에 완전히 회복.
 - 사망률은 1% 미만이며, 사망 원인은 지속되는 무호흡 발작, 교정되지 않는 심한 호흡산증, 그리고 빠른 호흡으로 인한 수분 손실이나 수분 섭취 감소로 인한 심한 탈수 등.
 - 세기관지염을 앓은 영아의 상당수에서 소아기 후반까지 기도 과민성(airway hyperreactivity)을 보임.

 - 세기관지염을 앓고 난 후 천식이 생기는 영아는 천식과 알레르기 질환의 가족력이 있으며, 세기관지염의 기간이 길고 담배 연기에 노출된 적이 있는 경우가 많음.
- 와 구각에 바른다.